

PDF ANONIMIZADO

ID publico: case_0147

Paginas del documento: 3

Copia anonimizada para verificacion metodologica.

Se removieron portada editorial, titulo, autores, afiliaciones, correos, DOI, URLs y metadatos del PDF original.

Las paginas restantes conservan el contenido util para revisar metodos, resultados, tablas y conclusiones.

Nota: la anonimización automatica prioriza reducir la identificacion directa del articulo. Los casos de una sola pagina o diseno no convencional deben revisarse manualmente antes de una publicacion abierta.

Rendón tiz

Autores

Asunto: Respuesta de carta al editor de los doctores Hernán Ramal-Aguilar y Adela Escobedo-Medina, Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo (Perú)

REFERENCIAS

1. Askie LM, Duley L, Henderson-Smart DJ, Stewart LA, PARIS Collaborative Group. Antiplatelet agents for prevention of pre-eclampsia: a meta-analysis of individual patient data. *Lancet*. 2007;369(9575):1791-8.
2. Publications Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine, Sibai BM. Evaluation and management of severe preeclampsia before 34 weeks' gestation. *Am J Obstet Gynecol*. 2011;205(3):191-8.
3. Crovetto F, Crispi F, Scazzocchio E, Mercade I, Meler E, Figueras F, et al. First-trimester screening for early and late small-for-gestational-age neonates using maternal serum biochemistry, blood pressure and uterine artery Doppler. *Ultrasound Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol*. 2014;43(1):34-40.
4. Stepan H, Herraiz I, Schlembach D, Verlohren S, Brennecke S, Chantraine F, et al. Implementation of the sFlt-1/PlGF ratio for prediction and diagnosis of pre-eclampsia in singleton pregnancy: implications for clinical practice. *Ultrasound Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol*. 2015;45(3):241-6.
5. Gómez-Arriaga PI, Herraiz I, López-Jiménez EA, Gómez-Montes E, Denk B, Galindo A. Uterine artery Doppler and sFlt-1/PlGF ratio: usefulness in diagnosis of pre-eclampsia. *Ultrasound Obstet Gynecol Off J Int Soc Ultrasound Obstet Gynecol*. 2013;41(5):530-7.
6. Bartsch E, Medcalf KE, Park AL, Ray JG. High Risk of Pre-eclampsia Identification Group. Clinical risk factors for pre-eclampsia determined in early pregnancy: systematic review and meta-analysis of large cohort studies. *BMJ*. 2016;353:i1753.
7. Sibai BM, Barton JR. Expectant management of severe preeclampsia remote from term: patient selection, treatment, and delivery indications. *Am J Obstet Gynecol*. 2007;196(6):514.e1-9.

Nuevamente agradecemos por el interés por el documento publicado dado que dicho tema es de interés en salud pública y las altas de tasa de prematuridad iatrogénica producida por la preeclampsia severa lejos del término.

Es importante, dentro de la evidencia, evaluar qué tanto nuestro estudio, como el estudio Mexpre Latin publicado por Vigil de Gracia fueron protocolos de manejo aplicados a la población Latinoamericana y no los podríamos extrapolar a las pacientes manejadas en población norteamericana, dado que las condiciones clínicas podrían variar y no serían comparables. Entendemos la preocupación emitida por ustedes ya que las guías actuales de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos consideran el manejo expectante a pacientes con preeclampsia severa antes de las 34 semanas de gestación y, de cierta forma, estamos comprometidos con estos protocolos de manejo de guías emitidas por sociedades importantes.

Por el momento, aunque nuestro estudio no genera un grado de recomendación fuerte por el tipo de diseño, actualmente la evidencia en Latinoamérica no recomendaría el manejo expectante en preeclampsia severa en los casos en que no se cuente con los recursos necesarios para la atención de la prematuridad y las complicaciones maternas con unidades de alta dependencia. Es importante anotar que para cada caso de preeclampsia lejos del término, una vez completada la maduración pulmonar, se debe realizar un manejo individualizado según los recursos de la institución, por lo cual quedaría a criterio del grupo tratante dado que actualmente tenemos una brecha de conocimiento real acerca de qué protocolo de manejo se debe ofrecer a estas pacientes dado que las revisiones sistemáticas no nos arrojan resultados claros.

icina maternofetal a fin de crear
adas a nuestra población y a los
disponibles en nuestros países.

Agradecemos nuevamente los comentarios realiza-
dos por el grupo de especialistas y por preocuparse por
la búsqueda de la información para contribuir en me-
jorar la salud de nuestras maternas de Latinoamérica.

César Augusto Rendón
Roberth A. Ortiz

Autores

REFERENCIAS

1. Rendón-Becerra CA, Ortiz-Martínez RA. Comparación de dos protocolos de Manejo en preeclampsia severa lejos del Término, y resultados maternos y neonatales: una cohorte histórica Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia). Rev Colomb Obstet Ginecol. 2016;67:26-35.
2. Vigil-De Gracia P, Reyes Tejada O, Calle Minaca A, et al. Expectant management of severe preeclampsia remote from term: the MEXPRES Latin Study, a randomized, multicenter clinical trial. Am J Obstet Gynecol 2013;209:425.e1-8.
3. Publications Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine, Sibai BM. Evaluation and management of severe preeclampsia before 34 weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol. 2011;205:191-8.

Popayán, 14 de septiembre de 2016

*Asunto: Respuesta de carta al editor del doctor
Elard I. Jiménez Garay, Universidad Privada
Antenor Orrego, Trujillo (Perú)*

Nuevamente agradecemos el interés por el docu-
mento publicado y damos nuestros comentarios con
respecto al tipo de diseño del trabajo. Es importante
anotar que la evidencia del estudio no es la más fuerte

dentro de las debilidades, dado que contamos con
poca evidencia y un solo ensayo clínico aplicado a
población latinoamericana en el estudio Mexpre, el
cual favorece al manejo activo. En nuestra opinión,
se debe generar más evidencia realizando nuevos en-
sayos clínicos aplicados a nuestra población latina y a
nuestros recursos disponibles, dado que no podemos
extrapolar los datos arrojados y los resultados neona-
tales de países desarrollados, por lo que nuevamente
enfaticamos que el manejo expectante debe ser indi-
vidualizado y aplicado a los recursos y las condiciones
maternas óptimas para mejores resultados neonatales,
dado que si no se cuenta con estas condiciones po-
dríamos aumentar los resultados maternos adversos.

Agradecemos nuevamente los comentarios rea-
lizados por el especialista y por preocuparse por la
búsqueda de la información para contribuir en me-
jorar la salud de nuestras maternas de Latinoamérica.

REFERENCIAS

1. Rendón-Becerra CA, Ortiz-Martínez RA. Comparación de dos protocolos de Manejo en preeclampsia severa lejos del término, y resultados maternos y neonatales: una cohorte histórica Hospital Universitario San José, Popayán (Colombia). Rev Colomb Obstet Ginecol. 2016;67:26-35.
2. Vigil-De Gracia P, Reyes Tejada O, Calle Minaca A, et al. Expectant management of severe preeclampsia remote from term: the MEXPRES Latin Study, a randomized, multicenter clinical trial. Am J Obstet Gynecol. 2013;209:425.e1-8.
3. Publications Committee, Society for Maternal-Fetal Medicine, Sibai BM. Evaluation and management of severe preeclampsia before 34 weeks' gestation. Am J Obstet Gynecol. 2011;205(3):191-8.